

عدوى المسالك البولية (UTI) تحدث عندما تنمو البكتيريا في المسالك البولية. معظمها عدوى المثانة، وتسبب حرقاً وإلحاحاً وتبول وكثرتة. وأحياناً تصل العدوى إلى الكلية وهو أشد خطورة. تختفي معظم حالات عدوى المسالك البولية (UTI) بسرعة بالمضاد الحيوي المناسب، وثمة وسائل فعالة لمنع التكرار.

عن هذه الحالة

عادةً ما تسبب عدوى المثانة (التهاب المثانة) ما يلي:

- حرقاً أو وخز عند التبول
- إلحاح وكثرة — تبول متكرر بكميات قليلة
- بول عكر أو داكن أو كريه الرائحة، وانزعاج في أسفل البطن

عدوى الكلية (التهاب الحويضة والكلية) أشد خطورة، وتُضاف إليها حمى وقشعريرة وألم في الظهر أو الخصرة وغيثان — وهذا يستوجب الرعاية الفورية.

الأسباب

تدخل البكتيريا (عادةً من الأمعاء) عبر الإحليل (مجرى البول) وتنمو في المثانة. من عوامل الخطر: الجماع، وانقطاع الطمث (انخفاض الإستروجين)، وعدم إفراغ المثانة بالكامل، والقسطرة، والحصوات، والسكري.

تعلم المصطلحات

UTI

عدوى في أي جزء من المسالك البولية.

التهاب المثانة

عدوى المثانة — النوع الأكثر شيوعاً.

التهاب الحويضة والكلية

عدوى الكلية — أشد خطورة وغالباً مصحوبة بحمى.

زراعة البول

فحص يُنبئ البكتيريا لاختيار المضاد الحيوي الأنسب.

عدوى UTI المتكررة

إصابات متعددة (2-3 مرات أو أكثر في السنة).

الإستروجين المهبلي

كريم أو أقراص بجرعة منخفضة تُقلل خطر عدوى UTI بعد انقطاع الطمث.

البيلة الجرثومية اللاعرضية

وجود بكتيريا في البول دون أعراض — لا تحتاج علاجاً في الغالب.

هل أحتاج دائماً إلى مضاد حيوي؟ إذا كانت لديك أعراض، تُعالج عدوى UTI بمضاد حيوي. لكن إذا كشف الفحص عن بكتيريا وأنت لا تشعر بأي أعراض، فعادةً لا يُوصى بالعلاج — إذ قد يكون ضاراً. استثناءات مهمة: الحمل وما قبل بعض إجراءات المسالك البولية.

كيف تُشخّص وتُعالج

معلومات مفيدة

- يؤكد فريقك الطبي التشخيص عبر الأعراض وفحص البول/الزراعة.
- تُعالج عدوى المثانة بدورة قصيرة من المضاد الحيوي.
- قد تستلزم عدوى الكلية مضاداً حيوياً أقوى أو أطول أمداً، وأحياناً رعاية في المستشفى.
- أكمل الدورة كاملةً حتى بعد تحسّن حالتك.
- تفيد منتجات التوت البري و D-mannose بعض المرضى؛ الأدلة متباينة — يمكن تجربتها.
- قد تستدعي عدوى UTI المتكررة البحث عن سبب كعدم الإفراغ الكامل أو الحصوات.
- إذا كنت تستخدم قسطرة، فوجود بعض البكتيريا أمر متوقع — يُبنى العلاج على الأعراض لا على الفحص وحده.

الوقاية من التكرار

- اشرب كميات وافرة من الماء ولا تحبس البول طويلاً.
- تبوّل بعد الجماع؛ امسح من الأمام إلى الخلف.
- بعد انقطاع الطمث، يُقلّل الإستروجين المهبلّي من خطر الإصابة.
- استفسر عن خيارات غير مضادات حيوية، وعن المضادات الوقائية فقط عند تكرار العدوى.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة أو ألم في الظهر/الخاصرة (احتمال عدوى الكلية)
- غثيان أو قيء، أو شعور بتدهور عام في الحالة
- دم واضح في البول، أو عدم تحسّن الأعراض بالمضاد الحيوي
- الحمل مع أي أعراض لعدوى UTI

ثلاثة أمور تُذكرها

1. معظم حالات عدوى UTI هي عدوى مثانة (حرقة والحاح) وتزول بدورة قصيرة من المضاد الحيوي؛ أما عدوى الكلية (حمّى وألم في الخاصرة) فأشد خطورة.
2. وجود بكتيريا في البول دون أعراض لا يستوجب العلاج عادةً — إلا في الحمل أو قبل بعض الإجراءات.
3. امنع التكرار بشرب السوائل والتبوّل بعد الجماع والإستروجين المهبلّي بعد انقطاع الطمث. اطلب الرعاية عند الحمّى أو ألم الخاصرة أو القيء.